



# 奥罗普切病毒病

2024年10月22日 | 阅读时间 15 分钟 (4094 字)

[English](#)

[العربية](#)

[Français](#)

[Русский](#)

[Español](#)

## 重要事实

- 奥罗普切病毒病（也称奥罗普切热）是一种患者通常会迅速从中恢复的发热性疾病。这种病由奥罗普切病毒引起，该病毒通过受感染的蠓叮咬传播给人类，一些蚊子也可能造成传播。
- 奥罗普切病毒主要存在于南美洲和加勒比地区。但是，2023年12月以来，全球报告了更多病例，2024年总计超过1万例，包括来自以前未检测到该病毒的地区。
- 奥罗普切病毒病与登革热和基孔肯雅热等其他疾病的症状相似，感染原因经常被误诊。
- 年，人们开始关注奥罗普切病毒感染可能出现的并发症，包括两名先前健康的受感染成人死亡，以及妊娠期间感染可能导致的不良后果，包括胎儿死亡、流产和新生儿小头畸形。这些都需要进一步调查和研究。
- 奥罗普切病毒病没有特异性治疗方法或疫苗，患者应接受支持性治疗。
- 主要可通过病媒控制和防止昆虫叮咬的个人防护措施来预防感染，包括推荐使用细网眼蚊帐、化学杀虫剂、防护服和驱虫剂。

## 概述

奥罗普切病毒病由奥罗普切病毒引起，可导致发热、头痛、关节痛、肌肉痛、寒战、恶心、呕吐和皮疹。大多数人会自行康复，但一些患者会出现严重症状。

奥罗普切病毒是一种节段性单链核糖核酸病毒，属于泛布尼亚病毒科正布尼亚病毒属，1955年首次在特立尼达和多巴哥的奥罗普切村发现(1)。

该病毒通过受感染的昆虫叮咬传播给人，通常是蠓，但也可能是蚊子。因此，它被称为由节肢动物传播的病毒（虫媒病毒）。在2023年底之前，奥罗普切病毒病的报告病例仅限于南美洲，主要是亚马逊雨林附近和加勒比地区。但自2023年12月以来，其他地区也发现了病例，且症状更加严重。2024年，已记录到非流行地区暴发疫情，出现两例确诊感染的致命病例，还发现存在母亲怀孕期间将疾病传播给婴儿的可能性。

# 分布和暴发

在基孔肯雅病毒和寨卡病毒2013年和2015年出现之前，奥罗普切病毒病是南美洲第二常见的虫媒病毒病（仅次于登革热）。

2023年底之前，巴西、玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、海地、巴拿马、秘鲁、特立尼达和多巴哥、法属圭亚那和委内瑞拉报告过奥罗普切病毒病；大多数病例报告发生在亚马逊雨林地区附近。但是，自2023年12月以来，报告的病例数量有所增加，包括在以前没有记录过传播的地区。

2024年，拉丁美洲和加勒比地区有7个国家[报告了](#)本地传播的奥罗普切病毒病：巴西、玻利维亚、哥伦比亚、古巴、圭亚那、秘鲁和多米尼加共和国(2-5)。此外，从存在本地传播的国家返回美国、加拿大、西班牙、意大利和德国的旅行者中也报告了奥罗普切病毒病例(6,7)。

## 传播

奥罗普切病毒主要通过帕拉库蠓叮咬传播给人类。致倦库蚊、委内瑞拉轱蚊和锯纹伊蚊也可能是传播媒介(8)。据信，该病毒存在两类循环：森林地区的森林循环以及昆虫与人之间的城市流行循环。在森林循环中，非人类灵长类动物、树懒和可能的鸟类是脊椎动物宿主，但尚未确定明确的节肢动物媒介。

正在开展进一步研究，以更好地了解目前疫情中的昆虫媒介和传播周期。

此前，没有确认的人际间传播报告。然而，2024年巴西有报告称，胎儿可能感染奥罗普切病毒，传播来源是怀孕期间感染的母亲。

## 症状

奥罗普切病毒的潜伏期（从被感染昆虫叮咬到首次出现症状的时间）通常为3至10天。该病的症状包括发烧、头痛、关节痛、肌肉痛、寒战、恶心、呕吐和皮疹。

大多数病例在症状出现后7天内完全康复。但是，有些患者可能需要数周时间才能康复，偶尔可能会发生严重的并发症，如无菌性脑膜炎。以前没有关于奥罗普切病毒感染导致死亡的描述。但是，2024年，有两份报告称以前健康的年轻人死于奥罗普切病毒感染。

## 诊断

由于与其他虫媒病毒(如登革热和基孔肯雅病毒)的临床表现相似，奥罗普切病毒病往往未被准确识别或出现误诊。

诊断奥罗普切病毒病需要进行逆转录聚合酶链反应和实时逆转录聚合酶链反应检测(9)。血清学检测可用于辅助诊断。但这些试验都应由受过高度训练的人员在配备有适当密封设施的实验室进行。目前还没有基于抗原或免疫测定法(如酶联免疫吸附试验、免疫层析法)的商业诊断或快速检测试剂盒。

## 治疗

没有针对奥罗普切病毒病的特异性治疗方法。治疗主要是支持性的，重点是缓解症状。

## 并发症

对奥罗普切病毒病并发症的了解很有限。偶尔会发生无菌性脑膜炎。

最近，来自巴西的报告描述了5例可能在怀孕期间发生奥罗普切病毒病传播的病例（4例死产和1例自然流产）以及4例通过回顾性调查发现的新生儿小头畸形病例。尽管通过对胎儿组织进行逆转录聚合酶链反应检测发现了病毒核糖核酸，但还不能得出奥罗普切病毒感染是胎儿死亡原因的结论。调查仍在进行。

## 预防与控制

没有可以预防奥罗普切病毒病的疫苗。病媒控制和个人防护措施是减少病毒传播的关键。

标准蚊帐对叮咬蠓的效果较差，因为这种昆虫很小，可以钻过蚊帐。相比之下，细网眼蚊帐和化学杀虫剂作为残留喷雾剂喷洒在受虫害房屋的内外墙壁上，已证明是有效的。

建议采取个人防护措施，如穿防护服和使用含有避蚊胺、IR3535或埃卡瑞丁的驱虫剂，以尽量减少感染风险。

## 世卫组织的应对

泛美卫生组织-世界卫生组织美洲区域办事处-与世卫组织会员国合作，正在积极监测奥罗普切病毒病的流行病学情况。

泛美卫生组织进行了一次快速风险评估。该评估表明，由于病例数量不断增加，已经扩散到新的地区，最近报告出现致命病例以及垂直传播的可能风险，区域风险很高(10)。泛美卫生组织已向世卫组织会员国发出警报，并就奥罗普切病毒病的诊断和临床管理、实验室诊断和监测以及预防和控制向后者提供了建议。

[了解更多关于泛美卫生组织的应对工作（英文）](#)

---

## 参考文献

1. Wessellmann KM, Postigo-Hidalgo I, Pezzi L, de Oliveira-Filho EF, Fischer C, de Lamballerie X, et al. Emergence of Oropouche fever in Latin America: a narrative review. *The Lancet Infectious Diseases*. 2024 Jul 1;24(7):e439–52.  
[https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099\(23\)00740-5/abstract](https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(23)00740-5/abstract)
2. Pan American Health Organization/World Health Organization. [Epidemiological Update Oropouche in the Americas Region - 15 October 2024](#). Washington, D.C.: PAHO/WHO;2024.
3. Pan American Health Organization/World Health Organization. [Epidemiological Update Oropouche in the Americas Region - 6 September 2024](#). Washington, D.C.: PAHO/WHO;2024.
4. Pan American Health Organization/World Health Organization. [Epidemiological Alert: Oropouche in the Region of the Americas, 1 August 2024](#). Washington, D.C.: PAHO/WHO;2024.
5. Pan American Health Organization/World Health Organization. [Epidemiological Alert: Oropouche in the Region of the Americas, 2 February 2024](#). Washington, D.C.: PAHO/WHO;2024.
6. Morrison A, White JL, Hughes HR, Guagliardo SJ, Velez JO, Fitzpatrick KA, et al. Oropouche Virus Disease Among U.S. Travelers – United States, 2024.MMWR Morb Mortal Wkly Rep [Internet].2024 Aug 27 [cited 2024 Aug 30];73(35).[https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/wr/mm7335e1.htm?s\\_cid=mm7335e1\\_w](https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/wr/mm7335e1.htm?s_cid=mm7335e1_w)
7. European Centre for Disease Control and Prevention. Threat assessment brief: Oropouche virus disease cases imported to the European Union. Stockholm: ECDC;2024 <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/threat-assessment-brief-oropouche-virus-disease-cases-imported-european-union>
8. de Mendonça SF, Rocha MN, Ferreira FV, Leite THJF, Amadou SCG, Sucupira PHF, Marques JT, Ferreira AGA, Moreira LA. Evaluation of *Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, and *Culex quinquefasciatus* Mosquitoes Competence to Oropouche virus Infection. *Viruses*.2021;13(5):755.<https://doi.org/10.3390/v13050755>
9. Pan American Health Organization/World Health Organization. Guidelines for the Detection and Surveillance of Emerging arboviruses in the Context of the Circulation of Other Arboviruses. Washington, D.C.: PAHO/WHO; 2024. Accessible at <https://www.paho.org/en/documents/guidelines-detection-and-surveillance-emerging-arboviruses-context-circulation-other>
10. Pan American Health Organization/World Health Organization. Public Health Risk Assessment related to Oropouche Virus (OROV) in the Region of the Americas. Washington, D.C.: PAHO/WHO;2024.  
<https://www.paho.org/en/documents/public-health-risk-assessment-related-oropouche-virus-orov-region-americas-3-august-2024>